TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJus)

NOTA TÉCNICA DO NATJUS Nº 3518/2026

Autos: 0804417-39.2026.8.12.0099 (fictício). Procedimento Comum Cível, Vara Única de Vila Boa Esperança.
Requerente: Gabriel Nunes Ferraz. Requeridos: Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Santa Aurora.

I. Enfermidade e linha terapêutica do SUS

Segundo o laudo e os demais documentos, o requerente é criança em idade escolar (entre 6 e 10 anos) com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (CID 10: F90.2). Os documentos descrevem agitação motora acentuada, hiperatividade, impulsividade e dificuldade de concentração, com prejuízo no desempenho escolar, há cerca de dois anos. Não foram apresentados resultados de exames complementares.

Princípio ativo	Posologia	Incorporado ao SUS?
Atomoxetina (Atentah)	40 mg, 1 comprimido ao dia	NÃO

O diagnóstico de TDAH exige avaliação clínica por profissionais capacitados, segundo critérios operacionais, porque os sintomas se confundem com outras condições e com características normais do desenvolvimento (Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do TDAH, Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 14, de 29/07/2022).

II. Tratamentos realizados e alternativas

Segundo os documentos médicos e o questionário da Defensoria Pública, o paciente já usou carbamazepina e biperideno, sem melhora do quadro.

O TDAH pede intervenção multimodal, incluindo medidas não medicamentosas (intervenções cognitivas e comportamentais, com destaque para a Terapia Cognitivo-Comportamental). Quanto aos psicoestimulantes, a Conitec avaliou metilfenidato e lisdexanfetamina para crianças e adolescentes com TDAH e recomendou a não incorporação, por evidências de baixa ou muito baixa qualidade e elevado impacto orçamentário; avaliou também a lisdexanfetamina para adultos, igualmente com recomendação desfavorável. Por isso esses medicamentos não são preconizados no PCDT.

III. O medicamento solicitado

Atentah (cloridrato de atomoxetina) é inibidor seletivo da recaptação da norepinefrina, indicado para TDAH em adultos, adolescentes e crianças com mais de 6 anos. Entre as reações adversas relatadas estão ansiedade, agitação, insônia, irritabilidade, agressividade, impulsividade e acatisia (bula do Atentah, Apsen Farmacêutica, 2023).

IV. Classe e registro na ANVISA

Medicamento	Classe terapêutica	Registro na ANVISA	Situação
Atomoxetina	Outros produtos que atuam sobre o sistema nervoso	Sim	Ativo

V a VIII. Risco, atendimento e oferta no SUS

Não há dados clínicos que indiquem risco iminente à vida. O paciente está sendo atendido pela rede pública de saúde. A atomoxetina não está incorporada na RENAME 2024 nem em outro ato normativo do SUS para o CID apresentado, razão pela qual não é possível indicar o ente responsável. Não há em tramitação solicitação de avaliação da atomoxetina, segundo a consulta pública a que este Núcleo tem acesso (página de tecnologias em avaliação da Conitec).

IX. Alternativas no SUS

A Política Nacional de Saúde Mental (Lei nº 10.216/2001) organiza a atenção em rede comunitária, com os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). O PCDT do TDAH (Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 14/2022) indica o tratamento preconizado pelo SUS. A RENAME 2024 padroniza no Componente Básico da Assistência Farmacêutica anticonvulsivantes (carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, valproato de sódio), antidepressivos (amitriptilina, clomipramina, nortriptilina, fluoxetina), antipsicóticos (clorpromazina, haloperidol) e ansiolíticos (clonazepam, diazepam).

X. Genérico e preço

A atomoxetina tem genérico e similar. Preço no Painel CMED/ANVISA, alíquota de 17%, consultado em 17/05/2026: ATENTAH (Apsen Farmacêutica S/A) 40 mg, caixa com 30 cápsulas. PF: R$ 103,96; PMC: R$ 138,57; PMVG: R$ 81,58.

XI. Conclusão

O paciente é atendido pela rede pública e não há risco iminente à vida; a atomoxetina não está incorporada na RENAME 2024 nem em outro ato normativo do SUS para o CID; não há pedido de avaliação em tramitação na Conitec; o PCDT do TDAH indica o tratamento do SUS e a RENAME 2024 padroniza os medicamentos listados acima. O fornecimento de medicamento não incorporado deve observar eficácia, segurança, custo-efetividade e impacto orçamentário (Temas 6 e 1.234 do STF), e não foram apresentadas evidências científicas robustas, como ensaios clínicos randomizados, meta-análises ou revisões sistemáticas, necessárias à avaliação da tecnologia pleiteada. Este Núcleo manifesta-se **desfavorável** ao pedido de atomoxetina.

17 de maio de 2026.

Equipe técnica do NATJus (médicos, enfermeiros e farmacêuticos)
assinado por certificação digital